

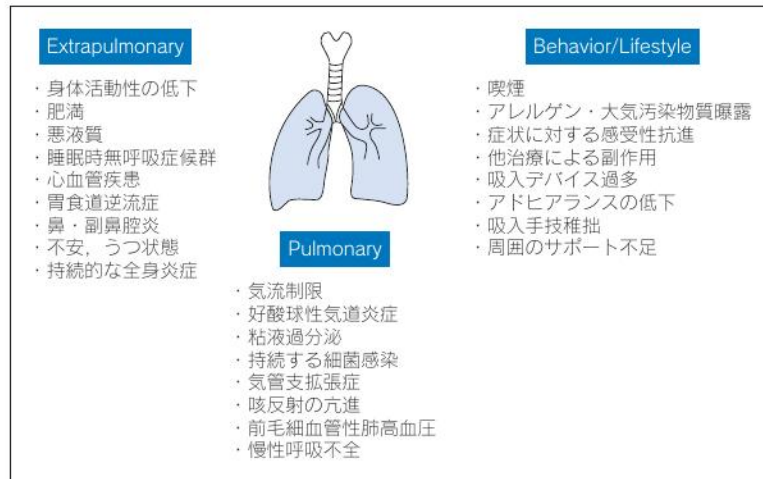


図 4 慢性気道疾患における Treatable traits
[日本アレルギー学会喘息予防・管理ガイドライン 2024WG（監修）：喘息予防・管理ガイドライン 2024，協和企画，p130，2024 より許諾を得て転載]

表 10 難治例への対応

治療によっても良好なコントロールが得られない場合の評価項目

鑑別診断 (喘息の判断は正しいか)	・喘息と間違えやすい疾患が鑑別されているか？ 誘発性咽頭閉塞症（Inducible laryngeal obstruction：ILO），気管支結核や肺癌による気道狭窄，気管軟化症，気管支拡張症，COPD，心不全，誤嚥，アンジオテンシン変換酵素阻害薬など薬物による咳嗽など
薬物療法の確認 (服薬アドヒアランスや吸入手技)	・吸入手技や服薬回数などの用法に誤りがないか？ ・長期管理の必要性が理解され，服薬アドヒアランスが良好か？ ・重症度やコントロール状態に応じた用量で薬剤が選択されているか？
合併症の管理	・喘息の重症化と関連する合併症の診断と治療が適切に行われているか？ 鼻炎，副鼻腔炎，COPD，胃食道逆流症，好酸球性多発血管炎性肉芽腫症，アレルギー性気管支肺真菌症，睡眠時無呼吸症候群，肥満，うつ病，不安症など
増悪因子の確認と排除	・増悪させ得る薬剤が服薬されていないか？ NSAIDs，β遮断薬など ・生活環境（家庭，職場，学校など）における増悪因子は適切に回避・除去されているか？ 喫煙（受動喫煙を含む），ダニ・真菌・ペットなどの感作アレルゲン，各種の環境中汚染物質（PM2.5，黄砂，エンドトキシンなど）など

[日本アレルギー学会喘息予防・管理ガイドライン 2024WG（監修）：喘息予防・管理ガイドライン 2024，協和企画，p131，2024 より許諾を得て転載]

アランスの確認，合併症の管理，増悪因子の確認と排除などを行う（図 4，表 10）。以上の対応を行ってもコントロール不良の難治性喘息患者に対しては，生物学的製剤の追加を検討する（図 5）。

f 急性増悪に対する対応

喘息の急性増悪とは「呼気流量の低下に起因する急性ないし亜急性の喘息症状の増加」である。喘息症状の悪化を自覚した場合に，家庭でどのような対応をすべきかを個々の患者の状況に合わせて指導しておく必要がある（アクションプラン）。喘鳴/胸苦しさのみから中等度までの喘息症状が出現した場合は，SABA を1～2パフ吸入する。効果が不十分な場合は1時間までは20分ごとに吸入を繰り返す。以後は1時間に1回を目安に吸入する。BUD/FM 吸入薬による SMART 療法（single inhaler maintenance and reliever therapy）を行っている患者の場合は，増悪時1吸入，数分間経過しても改善しない場合はさらに1吸入

追加する。これらの初期対応で症状が消失し，3～4時間効果が持続する場合はそのまま自宅治療とする。症状が改善せず，（表 11）に示す目安がある場合は，経口ステロイド薬（プレドニゾロン 15～30 mg：0.5 mg/kg 相当）を内服し，速やかに救急外来を受診するように指導する。

患者が来院したら増悪要因（表 12）および強度の判断（表 13）をただちに行う。急性増悪の強度は，わずかな喘鳴/胸苦しさから，呼吸困難感があるが横になれる程度の軽度（小発作），苦しくて横になれず，かろうじて歩行できる程度の中等度（中発作），歩行不能で，会話も困難な程度の高度（大発作），チアノーゼ，意識障害，さらに呼吸停止などを認める重篤に至るまでさまざまである。各々の増悪強度に応じた治療（増悪治療ステップ1～4）を行う（表 14）。

g 気管支喘息の予後

ICS を中心とした吸入療法の進歩や喘息ガイドライ